

04. LE SYSTEME CIRCULATOIRE MISE À JOUR

DURÉE : 03:59

FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo propose une mise à jour profonde du modèle traditionnel du système circulatoire, en démontrant qu'il existe en réalité trois systèmes veineux distincts. Vous apprendrez sur les interactions complexes entre le sang et le cœur, ainsi que sur les différentes voies que le sang peut emprunter, illustrant l'intelligence intrinsèque de la circulation. Les théories des pionniers comme M. Herveillat et M. Batson permettent de repenser les rôles des veines et de comprendre en détail les systèmes cardinal, vitellin et ombilical. Les implications pratiques sur des pathologies courantes, comme les lombalgies et les acidités locales, seront également abordées, vous offrant des outils concrets pour enrichir votre pratique ostéopathique.

LE SYSTÈME CIRCULATOIRE : MISE À JOUR

LE DÉVELOPPEMENT DES TRAJECTOIRES VASCULAIRES

L'image traditionnelle du **système circulatoire** est celle d'un circuit partant du cœur par les **artères** et y revenant par les **veines**. Bien que cela soit vrai, il existe en réalité trois systèmes veineux différents :

- **Un système vertébral** : exclusivement en relation avec le système vertébral.
- **Un système portal** : drainant tout le système **ectodermique**, **mésodermique** et **endodermique**.
- **Un troisième type de système veineux**.

Le sang revient effectivement au cœur, mais il peut également faire demi-tour ou emprunter d'autres trajectoires en fonction des pressions et des dépressions au niveau du cœur. Par exemple, si le système portal est trop chargé et ne peut pas assurer son retour, le sang empruntera une autre voie. Il utilisera un **système cave de retour** via des zones diaphragmatiques d'échange.

Cela signifie que les pressions peuvent s'ajuster. Le sang ne suit pas un simple circuit fermé, mais peut emprunter diverses voies. Il existe une **intelligence intrinsèque** à ce système, visant toujours à revenir au cœur.

UNE VISION RENOUVELÉE DU SYSTÈME VEINEUX

Le sang part bien du cœur et y revient. Cependant, notre vision du système veineux, et par extension du système circulatoire, date du XVIIe siècle. Cette conception est désormais **renovée**.

Les pionniers de cette nouvelle compréhension sont **M. Herveillat** et **M. Batson**. Une question se pose : "Mais on m'a toujours dit que les veines contenaient des valves pour empêcher le retour du sang." En réalité, ces valves ne sont présentes que dans les **grosses veines**, et non dans l'ensemble du réseau. Il n'y a que très peu de petites valves de ce type.

LES DIFFÉRENTS SYSTÈMES VEINEUX À ÉTUDIER

Nous allons étudier :

- **Les veines cardinales** : qui deviendront subcardinales et supracardinales.
- **Le système vitellin** : en rapport avec le foie.
- **Le système ombilical** : qui sera remappé dans le système vertébral-caval-portal et réintégré dans la pratique ostéopathique.

Le système cardinal se modifiera tellement que nous verrons en détail comment il forme des tissus et des structures qui s'intégreront à la fois dans les structures **ectodermiques** et **mésodermiques**.

Une méthode a été développée pour mettre cela en pratique. Il est crucial d'en avoir compris le sens.

IMPLICATIONS PRATIQUES ET CLINIQUES

Les **stases** et les changements de **pression abdominale** peuvent avoir des conséquences importantes. Par exemple, des **lombalgies** peuvent être la conséquence d'une surcharge du système portal.

Il est alors nécessaire de "décharger" le système vertébral par cette surcharge portale. C'est là qu'intervient l'ensemble du mécanisme des **discopathies**.

Toute forme de stase entraînera une **acidité**, même locale, qu'il faudra résoudre. Un même schéma est toujours utilisé. Par exemple, une **tumeur du sacrum** s'accompagne presque toujours de **métastases** au rein gauche, au poumon gauche et au cerveau. On observe une constante dans la trajectoire.

Dans les problèmes de **prostate**, on peut retrouver ce même schéma. De plus, il existe une **continuité vasculaire** entre les sinus vertébraux et les sinus sacrés du petit bassin.

Une prise de sang effectuée dans un bras ne reflète pas la totalité du sang qui pourrait être prélevé dans un système veineux, artériel ou autre.



FIG. — Système cardiovasculaire

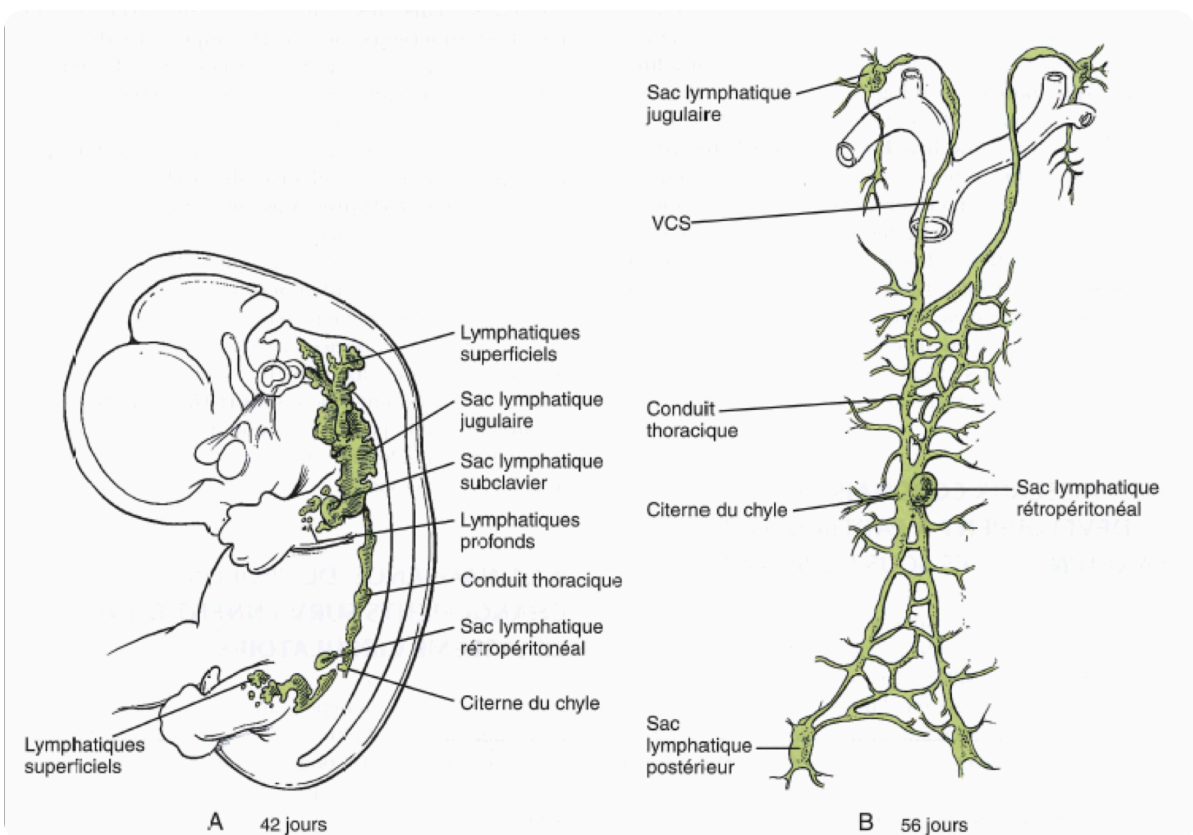


FIG. — Développement système lymphatique

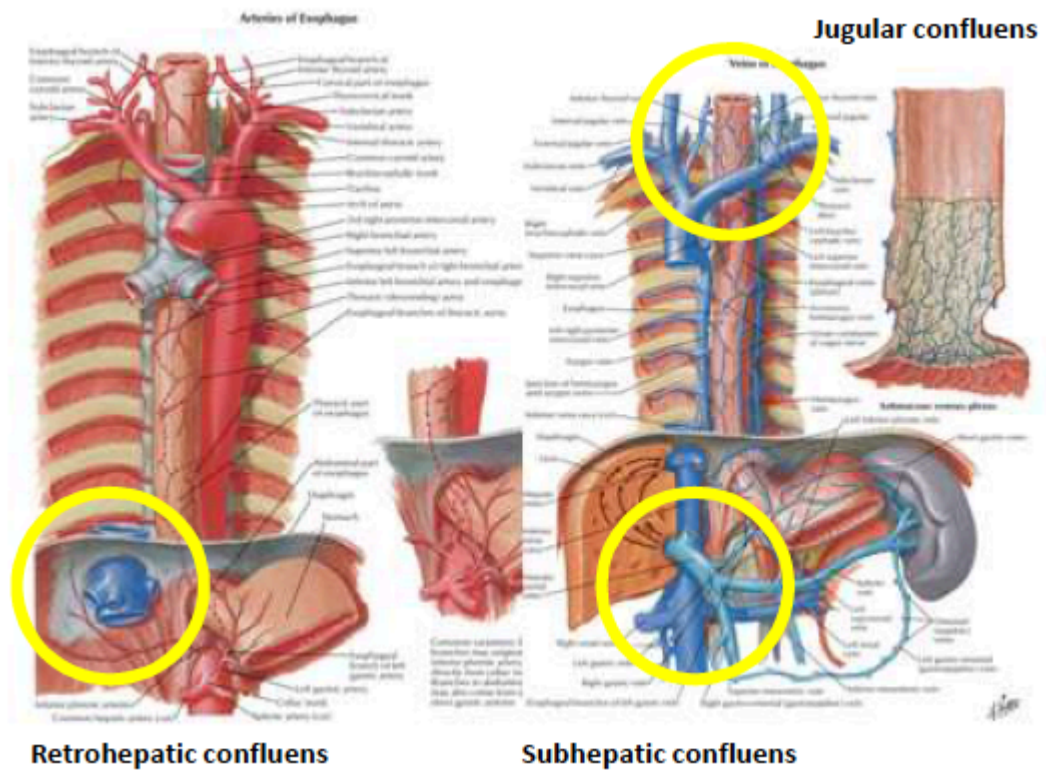


FIG. — Veines œsophagiennes collatérales

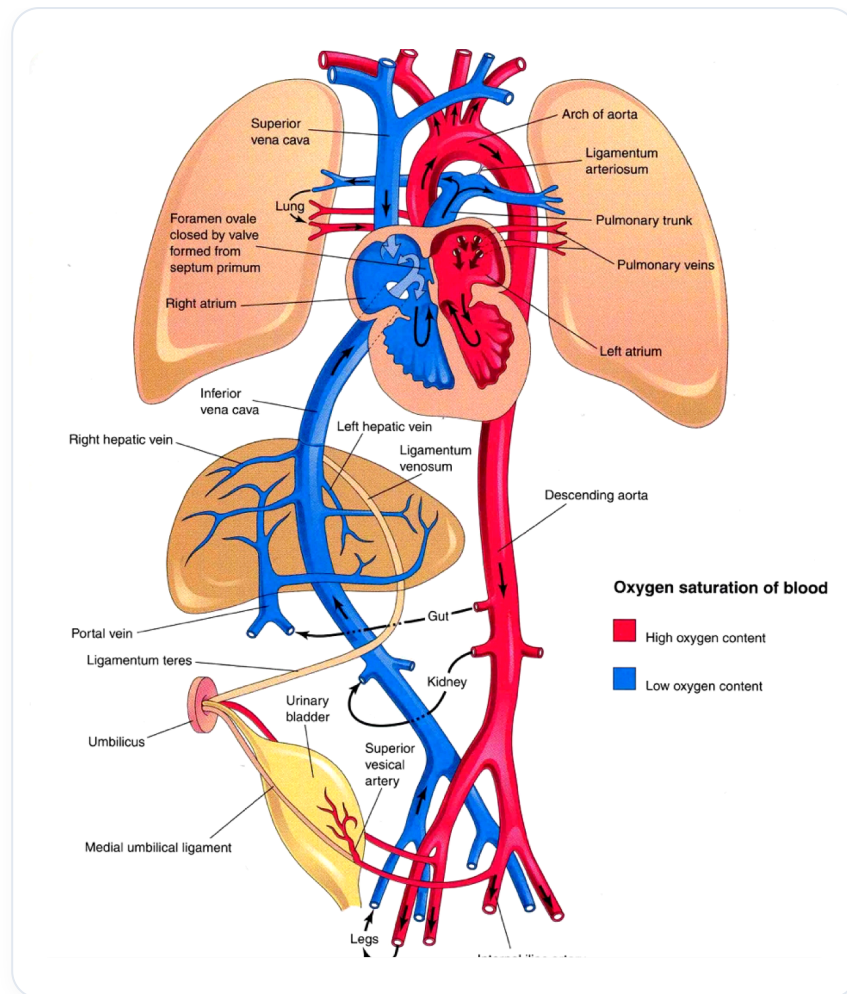


FIG. — *Circulation foetale humaine*